ZJKC01-2024-0009

丽水市人民政府办公室文件

丽政办发〔2024〕34号

丽水市人民政府办公室关于印发丽水市政策性长期护理保险实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，市政府直属各单位：

《丽水市政策性长期护理保险实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

丽水市人民政府办公室

2024年4月26日

（此件公开发布）

丽水市政策性长期护理保险实施方案

为扎实推进共同富裕，积极应对人口老龄化，解决长期失能人员的基本护理保障需求，根据《国家医保局 财政部关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）、《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省构建多层次长期护理保障体系实施方案的通知》（浙政办发〔2023〕73号）、《浙江省医疗保障局 浙江省财政厅印发<关于深化长期护理保险制度试点的指导意见>的通知》（浙医保联发〔2022〕6号）等要求，结合我市实际，制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心，推进建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续发展的长期护理保险制度。以共同富裕为目标，着力增强护理保障供给，减轻失能人员家庭照护负担，提升失能人员基本生活品质，引导和培育护理服务市场发展，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

二、目标任务

2024年起，建立全市统一、全民覆盖的政策性长期护理保险

（以下简称“长期护理保险”）制度，我市参加基本医疗保险的参保人员同步参加长期护理保险，有效减轻失能人员家庭长期护理事务性及经济负担。促进长期护理服务市场快速发展，服务供给显著增强，长期护理保险制度成为我市社会保障体系重要组成部分，有力推动共同富裕美好社会山区样板建设。

三、基本原则

（一）坚持以人为本。

着力增强长期护理服务保障，通过建立长期护理保险制度，有效降低重度失能人员及其家庭的长期护理保障负担，提升失能人员生活质量。

（二）坚持保障基本。

长期护理保险筹资与待遇水平总体平衡，立足解决基本护理需求，合理确定保障范围和待遇标准，确保制度稳健、可持续发展。

（三）坚持机制创新。

积极创新承保模式，引入社会力量参与长期护理保险承保服务，做好业务流程优化，提升服务效率，降低管理成本，提升管理和服务效能。

（四）坚持统筹协调。

做好长期护理保险与商业护理保险、基本医疗保险等社会保障制度的功能衔接，协同推进养老服务体系和健康产业发展。

四、长期护理保险主要内容

（一）参保范围。

在我市参加职工基本医疗保险（以下简称“职工医保”）、城乡居民基本医疗保险（以下简称“居民医保”）的参保人员，同步参加长期护理保险。

（二）资金筹集。

1. 筹资标准。长期护理保险基金按自然年度筹集。按以支定收的要求，筹资标准原则上按照我市上年度全体居民人均可支配收入的 2. 2‰左右确定，职工和居民实行统一筹资标准。按照低水平起步的原则，2024 年筹资标准确定为每人每年 45 元。今后年度由医保部门会同财政部门根据基金收支情况合理确定筹资标准，报市政府同意后执行。

2. 职工医保参保人员。在职职工参保人员长期护理保险费由个人和用人单位同比例（1：1）分担；退休人员由个人和职工医保统筹基金同比例（1：1）分担。个人缴费部分可从职工医保个人账户中代扣代缴。单位缴费部分从其缴纳的职工医保费中划转，不增加单位负担。参加职工医保的灵活就业人员，参照在职职工执行。

2024 年职工医保参保人员的个人缴费部分从职工医保统筹基金中划转。

3. 居民医保参保人员。筹资标准由个人和当地财政按 1: 2 的

比例分担，参保人员个人缴费部分在缴纳居民医保个人保费时一并缴纳。

2024 年居民医保参保人员的个人缴费部分从居民医保统筹基金中划转。

4. 参保资助。纳入特困、低保、低边范围的困难人员长期护理保险个人缴费部分所需资金由当地政府保障。各县（市、区）政府可参照居民医保保费征收规定，出台政策对其他特殊群体予以参保资助。

5. 完善筹资机制。逐步完善由用人单位、个人、医疗保险基金以及财政等共同分担的长期护理保险基金筹资机制。逐步优化职工缴费结构，单位缴费可通过医保费率平移转换等方式筹集资金。城乡居民筹资参照居民医保筹资模式和资助参保政策执行，优化财政资金投入结构。探索职工医保个人账户家庭共济等缴费模式。按照国家和省级政策规定，结合基金运行情况、城乡居民可支配收入，动态调整长期护理保险筹资水平。

（三）保障待遇。

1. 待遇享受条件。经医疗机构或康复机构规范诊疗、失能状态持续 6 个月以上或因年老失能，申请通过评估认定符合重度失能标准的参保人员，自作出评估结论次月起可按规定享受长期护理保险待遇。起步阶段重点解决长期重度失能人员基本保障需求，如遇国家放宽条件或调整标准，按规定调整。

2. 待遇支付范围。长期护理保险基金主要用于支付符合规定的机构和人员提供基本护理服务所发生的费用，护理服务包括生活照料服务和医疗护理服务等项目。具体护理服务项目另行确定。

下列情形发生的长期护理服务费用，不纳入长期护理保险基金支付范围：应当由医疗、工伤保险基金支付的；应当由第三人负担的；应当由公共卫生负担的；非协议管理定点机构发生的；其他法律、法规规定不予支付的。

对参保人员同时符合长期护理保险、养老护理补贴等申领条件的，原则上根据本人意愿享受其中一项补贴政策，并结合机构、社区和居家护理实际做好政策衔接。享受特困人员和完全失能低保老年人入住养老机构照护护理政策的对象，不再享受长期护理保险待遇。

3. 待遇支付标准。长期护理保险待遇不设起付标准，根据不同护理服务方式，实行差别化待遇保障政策。

（1）机构护理。机构护理是指由养老服务机构、残疾人托养机构、其他符合长期护理服务条件的企业或社会组织等长期护理保险定点服务机构提供规范护理服务，或由纳入定点护理服务范围的医疗机构在设立的长期护理服务专区提供规范护理服务。

机构护理纳入长期护理保险支付范围的费用由长期护理保险基金支付 70%。对医疗机构设立的长期护理专区收治的重度失能人员按基本医保总额预算下的复合型支付方式管理要求，符合条

件的可纳入按疾病诊断相关分组（DRGs）床日病组管理，不符合床日付费病组管理条件的纳入按疾病诊断相关分组（DRGs）普通病组管理。

（2）居家护理。居家护理包括全部由长期护理保险定点服务机构提供上门护理服务和机构提供上门服务与亲情护理相结合两种方式。居家护理服务原则上由长期护理保险定点服务机构专业护理人员开展，参保人员确有需求的，可在长期护理保险定点服务机构管理指导下，由经培训合格、具备规范服务能力的亲情护理人员（指亲属或特定关系人）提供基础的生活照料护理服务。基础的生活照料护理服务之外的专业生活照护、医疗护理服务由长期护理保险定点服务机构提供，具体政策由医保部门另行制定。

接受长期护理保险定点服务机构规范居家护理服务的，纳入长期护理保险支付范围的费用由长期护理保险基金支付80%。

（3）支付限额。支付限额按照失能等级和护理服务类型确定，具体标准由医保部门另行确定。

（4）待遇变更。失能人员经申请评估为新的失能等级的，从评估结论下达的次月起按照新的失能等级享受长期护理保险待遇。失能人员护理方式发生变更的，从变更的次月起按变更后的护理方式支付待遇。失能人员经治疗和复评后不符合重度失能评估标准或失能人员死亡的，终止享受长期护理保险待遇。

4. 费用结算管理。

（1）护理服务费。参保人员凭医保码或社会保障卡等介质，与长期护理保险定点服务机构实时结算长期护理保险待遇。应由个人承担的费用，由个人支付给长期护理保险定点服务机构；应由基金支付的费用，由医保经办机构与长期护理保险定点服务机构按月结算。

（2）失能评估费。参保人员的首次失能评估费、符合规定的失能等级复评费用从长期护理保险基金中列支。

5. 待遇支付管理。长期护理保险与基本医疗保险同步参保缴费后，其待遇享受起始时间与基本医疗保险一致。

（四）评估管理。

1. 评估制度。建立长期护理保险失能评估制度，明确管理要求和评估费用标准，按规定对符合条件的参保人员的失能程度、疾病状况、照护情况进行综合评估，作为享受长期护理保险待遇的依据。

2. 评估标准。失能评估按照浙江省长期护理失能等级评估标准执行。民政部门按规范组织开展的老年人能力评估结果，可作为认定失能等级的基础，由医保经办机构按规定进一步审核把关，确认后享受长期护理保险待遇。

3. 评估组织。成立市、县（市、区）长期护理保险失能评估委员会，负责按照省医保局等部门的规定健全失能评估管理制度和指导协调等工作，具体评估工作由医保经办机构会同承保机构

负责开展。按照国家和省级统一部署，积极探索委托第三方机构开展评估工作。

（五）机构管理。

依法设立并具备长期护理服务能力的养老服务机构、医疗机构（设立长期护理服务专区）、残疾人托养机构、其他符合长期护理服务条件的企业或社会组织等相关机构可以按规定申请为长期护理保险定点服务机构，长期护理保险定点服务机构与医保经办机构签订长期护理服务定点协议后为参保人员提供长期护理服务。

建立健全长期护理保险定点服务机构和从业人员的协议管理、监督稽核等制度，探索引入第三方监管机制，强化对长期护理保险服务的监管。

（六）承保管理。

积极创新长期护理保险服务管理模式，鼓励和引导保险公司采取联保共保等方式承保。具体由市医保部门牵头采用公开招投标方式选定2-5家服务能力强、经营信誉好的商业保险机构作为承保机构，由承保机构确定其中一家作为主承保机构。每一承保周期为3年。承保机构在医保部门指导监督下开展长期护理保险经办管理业务。

（七）基金管理。

1. 长期护理保险基金实行市级统筹，建立长期护理保险风险

金，长期护理保险风险金每年从筹集的保费按1%比例提取，风险金累计结余超过筹集保费的5%后不再提取。长期护理保险基金、长期护理保险风险金参照社会保险基金管理制度执行，纳入社会保障基金财政专户，实行预决算管理，单独建账、独立核算、专款专用，接受审计和社会监督。按照“收支平衡、略有结余”的原则，根据基金收支结余情况、经济社会发展水平等因素，科学确定长期护理保险筹资标准、待遇标准、支付范围等政策内容。

2. 建立健全长期护理保险基金监管机制，完善举报投诉、信息披露、内部控制、欺诈防范等风险管理制度，强化基金安全管控，提高基金使用效率，确保基金安全。

3. 参保人员符合待遇支付规定的护理服务费用、失能评估费用、购买委托经办服务的费用由长期护理保险基金支付。

4. 长期护理保险基金按年结算，当年收支存在缺口的，缺口部分由历年结余基金支付，历年结余基金不足支付的部分由长期护理保险风险金支付，仍不足的，各级政府按参保人数比例补足，并结合基金收支运行实际适时调整缴费比例或待遇支付政策。鼓励医保部门和承保机构在自愿协商的基础上探索建立符合地方实际的风险分担机制。长期护理保险风险金低于筹集保费1%时，可提高当年风险金提取比例，具体由医保部门会同财政部门研究确定。

（八）系统建设。

长期护理保险参保、缴费、评估、结算、监管实现全过程信息化、数字化管理。长期护理保险定点服务机构按要求统一接入系统，及时准确上传相关信息数据。

（九）调整机制。

根据长期护理保险政策调整情况、基金运行情况等因素，市医保部门牵头提出筹资标准、支付范围、支付限额等调整方案，经市政府同意后向社会公布执行。

五、政策衔接

（一）失能评估衔接。

已在“浙里惠民保”长期护理责任制度运行期间认定为重度失能的参保人员，重新发文明确后同步认定为长期护理保险重度失能人员，可按规定享受长期护理保险待遇。

（二）定点机构衔接。

已纳入“浙里惠民保”长期护理责任定点管理的机构，重新发文明确后同步纳入长期护理保险定点服务机构，与经办机构签订服务协议后继续为失能人员提供护理服务；已纳入为长期护理责任定点培训机构的单位，重新发文明确后也同步纳入长期护理保险定点培训机构。

（三）工作制度衔接。

各地重新发文确定长期护理保险失能评估委员会。长期护理保险相关配套管理制度另行发文明确。

（四）保障待遇衔接。

原已享受长期护理责任待遇的重度失能人员，以及2023年底前经评估认定为重度失能并通过长期护理保险定点服务机构、居家上门服务机构提供规范长期护理服务的人员参加2024年度长期护理保险后，其长期护理保险待遇可自2024年1月1日起享受。2024年度申请通过评估认定符合重度失能标准的参保人员，自作出评估结论次月起可按规定享受长期护理保险待遇。

六、保障措施

（一）提高思想认识。

各地各部门要充分认识建立长期护理保险制度对于强化失能人员长期护理保障水平，推动构建多层次长期护理保障体系的重要意义。坚持以人民为中心的思想，紧扣国家和省级相关工作要求，强化部门协同，压实工作责任，扎实推进长期护理保险政策贯彻落实，为我市多层次长期护理保障体系建设打下坚实基础。

（二）明确职能分工。

市医保局负责全市长期护理保险统一管理工作，负责牵头制订实施细则，成立失能评估工作机构，建立健全失能评估办法、长期护理保险定点服务机构管理办法、长期护理保险服务监督管理办法等配套管理制度；负责指导经办机构开展长期护理保险服务管理工作，牵头动态调整保费标准和待遇保障水平，会同相关部门加强基金使用监督管理等工作。各级医保经办机构负责长期

护理保险经办规程、服务标准的制定和落实，指导和监督承保机构落实经办服务等工作。

市民政局负责规划、统筹配置养老服务资源，加快养老机构护理型床位建设，推动养老服务产业发展；负责长期护理中各类生活护理服务的技术指导、居家亲情护理家庭照护者培训等工作。

市卫生健康委负责规划和统筹配置医疗服务资源，推动医疗服务产业发展，落实家庭病床和家庭医生签约服务制度，指导相关医疗机构设立长期护理专区，加强医疗机构护理性床位与治疗性床位分类管理；负责长期护理工作中各类医疗护理服务的技术指导、参与失能评估等工作。

市财政局负责长期护理保险基金和风险金管理等工作。

国家金融监管总局丽水监管分局负责对长期护理保险商业承保机构的监督管理以及商业长护险产品开发指导等工作。

市人力社保局负责按规定支付护理服务行业从业人员执业技能培训补贴、评定职业技能水平等工作。

市教育局负责我市各类院校的长期护理专业规划设置和专业技术人员培养等工作。

市税务局负责做好长期护理保险保险费征缴等工作。

市审计局按照职责做好本办法的监督管理。

市残联、市市场监管局等有关部门按照各自职责，共同做好本办法的实施工作。

长期护理保险承保机构配合落实失能评估、权益登记、待遇支付、审核以及协助做好定点服务机构协议管理等工作。

各县（市、区）负责本辖区内长期护理保险的政策宣传、参保缴费、待遇结算服务和管理工作。

（三）培育护理市场。

大力发展护理服务市场，支持社会资本创办各类养老护理结合机构和专业护理机构，鼓励发展社区居家护理，支持社区居家养老服务机构建设，提高社区护理服务能力。鼓励具备条件的高等院校、高职院校、培训机构、服务企业等培养专业护理服务人员，提高护理服务质量。

（四）创造良好氛围。

各地各部门要强化宣传引导，加强政策解读，合理引导预期，增强全社会的保险责任意识，争取广大群众和社会各界的理解支持，凝聚社会共识，构建良好的社会氛围。

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，丽水军分区，市监委，市法院，市检察院。

丽水市人民政府办公室　　2024年4月26日印发